



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سلوي احمد محمد حصوه

العنوان : 11ش العروبة جزيرة
دار السلام القاهرة

الحي / المدينة : دار السلام

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

رقم البطاقة : 26401180102607 رقم التليفون : 01285421698

العمر (تاريخ الميلاد) : 18-01-1964 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج بعقار TDM1 وريدي [14121] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سلوي احمد محمد حصوه National ID: 26401180102607	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي IV (trastuzumab emtansine) TDM1
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



MDT FORM 23/ 8 / 2025 G

Name	د. نوري أحمد محمد	MRN	175112025
Age	61 yrs	ID	
Menopausal status	post menopause	Phone	012727-70
NRS SCORE		Marital status	0112498007
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	PTN	REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: IDC, GII

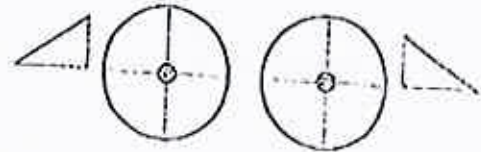
ER:	PR:	HER2:	KiTV:
7/8	8/8	(+2)	10%

Sonomammography: amplified by sish

R

MDT

LA DCE



CTNM
430

Mets Workup:

Recommendations:

- IHC Revealed that Her2 +2 (amplified by sish) [Revision]
- she Received 2 Cycles of AC.

MDT for TCHP

MDT OUTCOME & PLAN

MDT for Adjuvant Therapy
for Breast CA
TCHP X 6 → 11/24

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Patient Name : الأستاذ / ماري احمد محمد محمود
Patient No. : 26401180102607
Path No. : 1562/25
Sex : Female
Age : 61 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001018
Request Date : 30/04/2025
Verification Date : 11/05/2025
Financial Category : خدمة المريض - نتائج الدورية
Department : Out Patient
Registered by : manwa mohamed youss

Pathology Report

Invasive duct carcinoma, Grade 2.
IPT:

- E-cadherin: Positive.
- ER: Positive (score 7/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- SISH: Amplified, Group I.
- (Average Her2 copy No.: (4.6), Her2/CEP17 ratio: (2.2)).
- Ki67%: 10%.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, Intense > 10% of tumor cells.

ISH groups:

The ratio is calculated and the results is interpreted as:

Verified by:

DR. Menna Nabil

Printing Date : 19/07/2025 09:53:33

Page 2 of 3

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



المرحلة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mar El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / ماري أحمد محمد محمود
Patient No. : 26401180102607
Path No. : 1562/25
Sex : Female
Age : 61 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001018
Request Date : 30/04/2025
Verification Date : 11/05/2025
Financial Category : فئة الأمانة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Amended Report

Clinical Data: Left breast locally advanced lesion.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 30/4/2025 at 11.30 am.

Gross Examination:

- Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), Ki67 clone (30-9) & SISH.

Microscopic Examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 1).
- Ductal carcinoma in situ: Not detected.
- Perineural invasion: Not detected.
- Angioinvasion: Not detected.
- IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- E-cadherin: Positive.
- ER: Moderate nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 7/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Faint complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 2+).
- SISH: Amplified.
- (Average Her2 copy No.: (4.6), Her2/CEP17 ratio: (2.2)).
- Ki67: 10% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy.

Verified by :
DR. Menna Nabil

Printing Date : 19/07/2025 09:53:33

Page 1 of 3

Printing by : Mrs. Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - New El Qadima - Cairo, Egypt

M. F. Ghosh

ECHO REPORT

Name:

Date: 15 / 9 / 2025

EF	62%	55-75%	PWT	0.6	0.6-1.1cm
LV EDD	4.7	3.5-5.8cm	AO.R	2.5	2-3.7cm
LA ESD	2.8	2-4cm	LA	3.6	2-4cm
FS	28%	25-45%	RV		0.7-2.3cm (supine)
SWT	0.7	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

L.V dimensions Normal

L.V wall thickness Normal

L.V diastolic function C.I

SWM/ No ROMA

LA and AO root dimensions Normal

Mitral valve N

Aortic valve

Tricuspid valve N

Pulmonary valve

Right side and systolic function LA PSE: 2.6

Intracardiac masses and effusion

Dr. *M. F. Ghosh*

Patient Name : الأستاذ / ماري أحمد محمد محمود
Patient No. : 26401180102607
Path No. : 1562/25
Sex : Female
Age : 61 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001018
Request Date : 30/04/2025
Verification Date : 11/05/2025
Financial Category : ثالثة الدولة - مستشفى روسي
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

- Group I (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.
- Group II (Negative): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4. (Recounting give the same result).
- Group III (Positive): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 6 (Recounting give the same result).
- Group IV (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4 but less than 6. (Recounting give the same result).
- Group V (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4.

Signature
Prof. Dr. Maha Guimei.
Dr. Duaa Mohamed.

Verified by :
DR. Menna Nabil

Printing Date : 19/07/2025 09:53:33

Page 3 of 3

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



حرفه رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مبنى القديسة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Mir El Qadima - Cairo, Egypt

Patient ID: 81175	Patient Name: Eng. A. Silvia Ahmed Mohamed Hassan
Age: 61	2025/04/10 11:07:16 AM: Report Date

Women's Health Outreach Program
Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 61 y old lady coming with left palpable mass with skin changes.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views. High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- Scattered dense fibro glandular parenchyma (ACR B).
- UOQ focal asymmetry associated with distortion and overlying skin dimple seen in (CC view).
- Ultrasound demonstrated corresponding UOQ Irregular hypoechoic non parallel mass with surrounding (desmoplastic reaction), seen at 3 o'clock inner zone measuring (2.8x2cm) with anterior ductal extension reaching nipple causing nipple retraction.
- Less than 3 indeterminate axillary level 1 LNs showing eccentric hilum reaching about (0.5cm).

Right breast

- Scattered dense fibro glandular parenchyma (ACR B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Impression:

Left breast (BIRADS 4c): UOQ suspicious solid mass with nipple infiltration.

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Recommendations:

Biopsy was done at same sitting.

Dr. Reham Rady, FRCR, FRCR